

ทบทวน... กฎหมายสาธารณสุขที่ เกี่ยวข้องกับการประกอบ วิชาชีพการพยาบาลและการ ผดุงครรภ์



ผศ.ดร.วัลยา ตูพานิช และ อ.อภิษฎา กั่งซ่า
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์และเวชศาสตร์เขตเมือง
คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช



หัวข้อ

01

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2539 และ ข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการ ผดุงครรภ์ พ.ศ. 2564

02

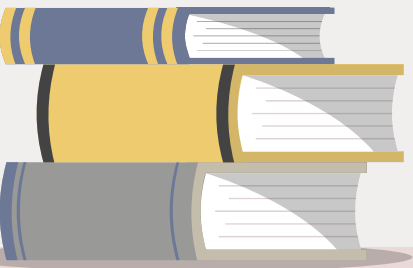
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

03

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545

04

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550



ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2539 (ต่อ)



พยาบาลวิชาชีพสามารถประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้ ตามเงื่อนไข



- ① ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขตามที่กำหนด
- ② เป็นการปฏิบัติราชการหรืออยู่ในระหว่างการปฏิบัติราชการตามหน้าที่หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
- ③ อยู่ในความควบคุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม => แพทย์

- ด้านอายุรกรรม => ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้น/การรักษาพยาบาลอื่นตามอาการที่กำหนด
- ด้านศัลยกรรม เช่น ผ่าตัด/สิ่งแปลกปลอมบริเวณไม่อันตราย เย็บบาดแผลที่ไม่สาหัส
- ด้านสูติ-นรีเวชกรรม เช่น ทำคลอดปกติ ฉีด/จ่ายยาเม็ดคุมกำเนิด ใส่และถอดห่วงอนามัย(ต้องอบรมก่อน)
- ด้านปัจจุบันพยาบาล => ปฐมพยาบาล
- การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
- การเจาะเลือดจากปลายนิ้ว/หลอดเลือดดำ
- การให้ยาสลบแบบ GA
- การให้ยาเพื่อประกอบวิชาชีพเวชกรรมตามบัญชียาที่กำหนด

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2539 (ต่อ)



ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง สามารถประกอบวิชาชีพเวชกรรมภายใต้ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2539 ดังนี้

1. ด้านอายุรกรรม

1.1 ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้น เพื่อบรรเทาอาการหรือโรคดังนี้ คือ ไข้ตัวร้อน ไข้และมีผื่นหรือจุด ไข้จับสั่น ไอ ปวดศีรษะ ปวดหลัง ปวดเอว ปวดท้อง ท้องผูก ท้องเดิน คลื่นไส้อาเจียน การอักเสบต่าง ๆ โลหิตจาง ดีซ่าน โรคขาดสารอาหาร อาหารเป็นพิษ โรคพยาธิลำไส้ โรคบิด โรคหวัด โรคหัด โรคสุกใส โรคคางทูม โรคไิกกรน โรคผิวหนัง และโรคติดต่อตามโครงการของกระทรวงสาธารณสุข

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2539 (ต่อ)

1. ด้านอายุรกรรม (ต่อ)

1.2 การรักษาพยาบาลอื่น คือ



การให้น้ำเกลือในผู้ป่วยต้องเดินอย่างรุนแรง



การฉีดยาแก้พิษงู ไม่ฉีดที่ รพ.สต.



การสวนปัสสาวะ



การล้างกระเพาะอาหารโดยใช้สายยางในรายที่สงสัยว่ารับประทาน

สารพิษ

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2539 (ต่อ)

2. ด้านศัลยกรรม



ผ่าฝี



เย็บบาดแผลที่ไม่สาหัส



ชะล้าง ทำแผล ตักแต่งบาดแผล



ผ่าเอาสิ่งแปลกปลอม

ซึ่งอยู่ในตำแหน่งซึ่งไม่เป็นอันตรายต่ออวัยวะสำคัญของร่างกายออก

โดยฉีดยาระงับความรู้สึกทางผิวหนัง

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2539 (ต่อ)

3. ด้านสูตินรีเวชกรรม



ทำคลอดในรายปกติ

-อายุครรภ์ => 37-42 wks

-ท่าของทารกในครรภ์ => ท่าศีรษะ

-กระบวนการคลอดเป็นไปตามธรรมชาติ => ส่วนนำเคลื่อนต่ำ

ปากมดลูกเปิดและบาง และไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนในระยะคลอด



ทำการช่วยเหลือขั้นต้นในรายที่มีการคลอดผิดปกติ



ทำการช่วยเหลือในกรณีที่จะมีการแท้งหรือหลังแท้งแล้ว

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2539 (ต่อ)



3. ด้านสุตินรีเวชกรรม (ต่อ)

- การวางแผนครอบครัว การฉีดยาคุมกำเนิด การจ่ายยาเม็ดคุมกำเนิด
- การใส่และถอดห่วงอนามัย ต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรของกระทรวง

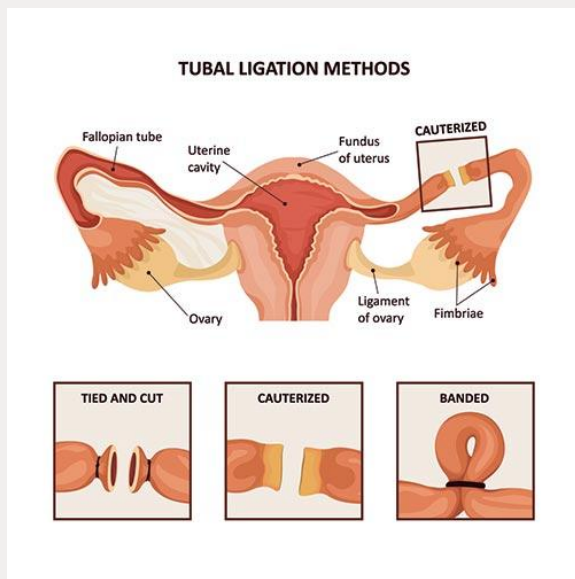
สาธารณสุข กระทำภายใต้เงื่อนไข

- ◆ มีการทดสอบผู้รับการใส่ห่วงอนามัยแล้วว่าไม่ตั้งครรภ์
- ◆ ผู้รับการใส่ห่วงอนามัยได้คลอดบุตรมาแล้ว 45-60 วัน และยังไม่มีการประจำเดือน
- ◆ ผู้รับการใส่ห่วงอนามัยแท้งลูกมาแล้ว 30 วัน และยังไม่มีการประจำเดือน

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2539 (ต่อ)

3. ด้านสูตินรีเวชกรรม (ต่อ)

- การผ่าตัดทำหมันหญิงหลังคลอด หรือการใส่และถอดยาฝังคุมกำเนิด โดยผ่านการอบรมในหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

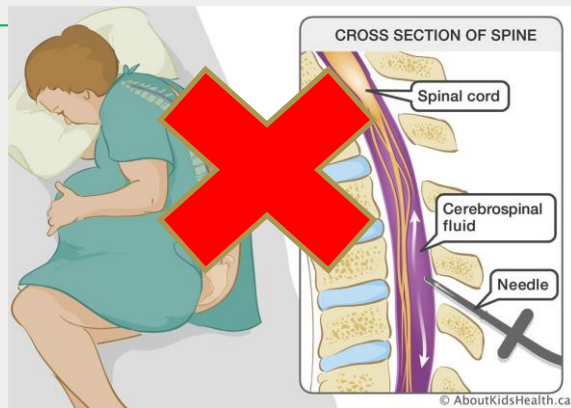




ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2539 (ต่อ)

4. การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค รวมถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรค

5. การให้ยาสลบชนิด General anesthesia ไม่รวมถึงการให้ยาชาทางไขสันหลัง หรือยาระงับความรู้สึกทางไขสันหลัง ผู้ปฏิบัติต้องได้รับประกาศนียบัตรการศึกษาหรือ
อบรมในหลักสูตรวิชาชีพพยาบาลและอยู่ในความควบคุมดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพเวช
กรรมอย่างใกล้ชิด



ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2539 (ต่อ)

6. การใช้ยาเพื่อประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามบัญชียาที่หน่วยงานราชการกำหนด โดยต้องไม่เกินรายการบัญชียาสามัญประจำบ้านตามกฎหมายว่าด้วยยา รายการยาสถานื่อนามัย และรายการสมุนไพรสำหรับงานสาธารณสุขมูลฐาน

●ประกาศรายการยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน (ล่าสุด พ.ศ. 2568)

<https://drug.fda.moph.go.th/media.php?id=796902948843167744&name=81120.pdf>

●ประกาศรายการยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ

<https://drug.fda.moph.go.th/media.php?id=514489733896871936&name=Law03-07-03.pdf> (ประกาศรายการล่าสุด 2556)



ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2539 (ต่อ)

7. การเจาะโลหิตจากปลายนิ้วหรือหลอดเลือดดำเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือเพื่อบริจาคเข้าธนาคารเลือด

8. ด้านปัจจุบันพยาบาล ให้การปฐมพยาบาลเกี่ยวกับการได้รับสารพิษ และสัตว์มีพิษกัดต่อย การแพ้ยาล การแพ้เซรุ่มและวัคซีน การเสียโลหิต ภาวะช็อค การเป็นลมหมดสติ หายุดหยาใจ กระตุกหัก ข้อเคล็ด ข้อเคลื่อน ชัก จมน้ำ ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ไฟฟ้าดูด สิ่งแปลกปลอมเข้าตา หู คอ จมูกและกระเพาะอาหาร และผู้ป่วยที่เจ็บหนัก

ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบ วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2564

การพยาบาล

- 1.การกระทำต่อร่างกายและจิตใจของบุคคล การตรวจประเมินภาวะสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการบาดเจ็บ การควบคุมการแพร่กระจายโรค การปฐมพยาบาล การบำบัดโรคเบื้องต้น และการฟื้นฟูสภาพทั้งรายทั่วไป รายที่ยุ่งยาก ซับซ้อน หรือเป็นการเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือวิกฤต
- 2.การสอน การแนะนำ การให้คำปรึกษาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย การวางแผนการดูแลต่อเนื่อง และการเสริมสร้างพลังอำนาจในการดูแลตนเองของประชาชน
- 3.การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การควบคุมและการแก้ปัญหาคาความเจ็บป่วย

ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบ วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2564

การพยาบาล (ต่อ)

4. การปฏิบัติการพยาบาลตามแผนการพยาบาลและ/หรือแผนการรักษาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม การใช้เครื่องมือพิเศษ การติดตามผล รวมทั้งการประสานทีมสุขภาพในการจัดบริการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการพยาบาลที่สภาการพยาบาลประกาศกำหนด

5. การให้การพยาบาลที่บ้านและการส่งเสริมความสามารถของบุคคล ครอบครัวและชุมชน เพื่อใช้ชีวิตอย่างปกติสุขหรือสามารถจัดการวิถีชีวิตให้อยู่กับความเจ็บป่วยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามศักยภาพ

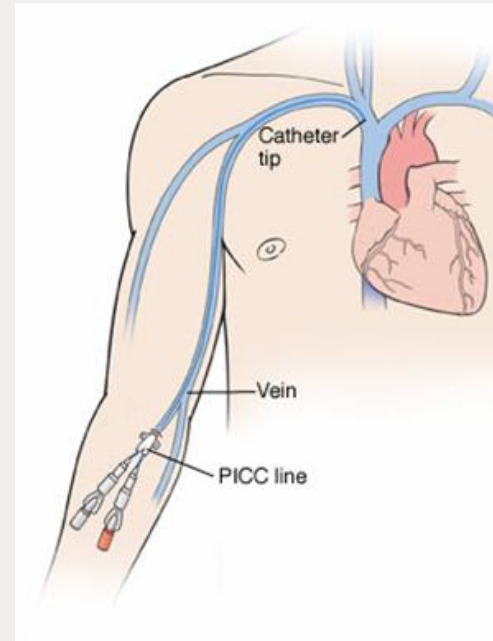
ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบ วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2564

การพยาบาล (ต่อ)

6. การให้ยาผู้รับบริการได้เฉพาะที่ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมซึ่งเป็นผู้บำบัดโรคได้ระบุไว้ในแผนการรักษาหรือเมื่อเป็นการรักษาโรคเบื้องต้นหรือการปฐมพยาบาล โดย

- ห้ามให้ยาหรือสารละลายในช่องรอบเยื่อไขสันหลัง หรือช่องไขสันหลัง หรือสายสวนทางหลอดเลือดดำส่วนกลาง (Peripherally Inserted Central Catheter) และช่องทางอื่นตามที่สภาการพยาบาลกำหนด

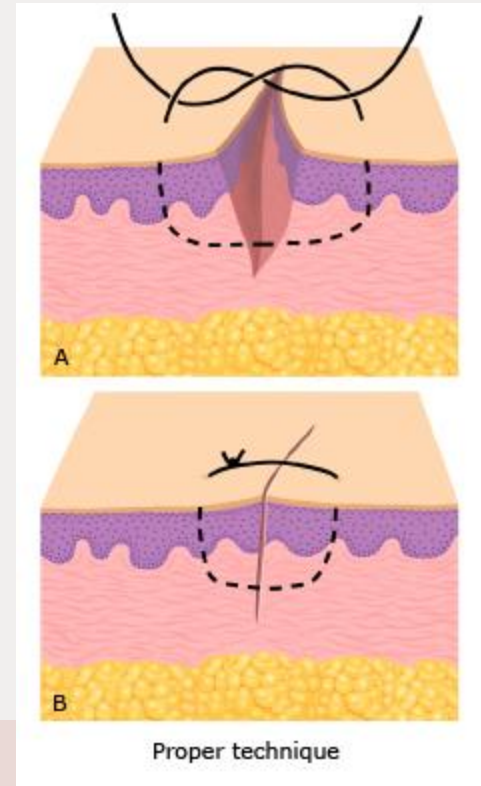
- ห้ามให้ยา หรือสารละลาย หรือสารที่เกี่ยวข้องกับรังสีวินิจฉัย และยาอื่นตามที่สภาการพยาบาลกำหนด



ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบ วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2564

การทำหัตถการ

1. การทำแผล การตกแต่งบาดแผล การเย็บแผล ขนาดเล็กไม่เกินชั้นเนื้อเยื่อไขมันใต้ผิวหนัง (subcutaneous tissue) และไม่อยู่ในตำแหน่งซึ่งเป็นอันตรายต่ออวัยวะสำคัญของร่างกาย โดยใช้ยาระงับความรู้สึกเฉพาะที่ หรือการตัดไหม ในตำแหน่งที่ไม่เป็นอันตราย การดูแลรักษาบาดแผลไฟไหม้ แผลน้ำร้อนลวก หรือสารเคมีไม่เกินระดับ 2 ของแผลไหม้



ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบ วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2564

การทำหัตถการ (ต่อ)

2. การผ่าตัดเอาสิ่งแปลกปลอม การผ่าฝี การผ่าตัดตาปลา การเลาะก้อนใต้ผิวหนังในบริเวณที่อยู่ในตำแหน่งซึ่งไม่เป็นอันตรายต่ออวัยวะที่สำคัญของร่างกาย โดยใช้ยาระงับความรู้สึกทางผิวหนังหรือฉีดยาชาเฉพาะที่ ในการเอาสิ่งแปลกปลอมออกจากอวัยวะ
3. การถอดเล็บ การจี้หูดหรือจี้ตาปลา โดยใช้ยาระงับความรู้สึกทางผิวหนังหรือฉีดยาชาเฉพาะที่



ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบ วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2564

การทำหัตถการ (ต่อ)

4. การให้ออกซิเจน

5. การให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำในผู้ป่วยที่มีภาวะวิกฤต ภาวะสูญเสีย
สมดุลของสารน้ำในร่างกาย ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อภาวะช็อค การปฐมพยาบาล หรือ
ตามแผนการรักษาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบ วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2564

การทำหัตถการ (ต่อ)

6. การให้ยาทางปาก ทางผิวหนัง ทางหลอดเลือดดำ หรือช่องทางอื่น ๆ ตามแผนการรักษาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือตามที่สภาการพยาบาลประกาศกำหนด (ดูประกาศสภาการพยาบาล)
7. การให้เลือด (Blood Transfusion) ตามแผนการรักษาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
8. การเปิดทางเดินหายใจให้โล่งด้วยการดูดเสมหะ การเคาะปอด
9. การช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardio Pulmonary Resuscitation) เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติของผู้ป่วย
10. การเช็ดตา ล้างตา (Eye Irrigation) หยอดตา ป้ายตา ปิดตา หรือการล้างจมูก



ประกาศสภากาการพยาบาล

เรื่อง ห้ามมิให้ยา Diclofenac ชนิดฉีด

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 20 ธ.ค 62 มีผลใช้บังคับ 21 ธ.ค 62



ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบ วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2564

การทำหัตถการ (ต่อ)

11. การสอดใส่สายยางลงไปในกระเพาะอาหาร (Nasogastric tube) เพื่อให้อาหาร ให้น้ำ หรือล้างกระเพาะอาหารในรายที่กินสารพิษ หรือตามแผนการรักษาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
12. การสวนปัสสาวะ หรือการเปลี่ยนสายสวนปัสสาวะในรายที่ไม่มีความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะ
13. การสวนทางทวารหนัก ในรายที่ไม่มีการขี้ขึ้นอันตราย
14. การตาม หรือการใส่เฝือกชั่วคราว
15. การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบ วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2564

การทำหัตถการ (ต่อ)

16. การเจาะเก็บตัวอย่างเลือดจากหลอดเลือดดำส่วนปลายหรือปลายนิ้ว หรือสารคัดหลั่ง เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตามข้อบังคับหรือประกาศที่สภาการพยาบาลประกาศกำหนด (ดู ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562)

17. หัตถการอื่น ๆ ตามที่สภาการพยาบาลประกาศกำหนด

ข้อบังคับสภาการพยาบาล

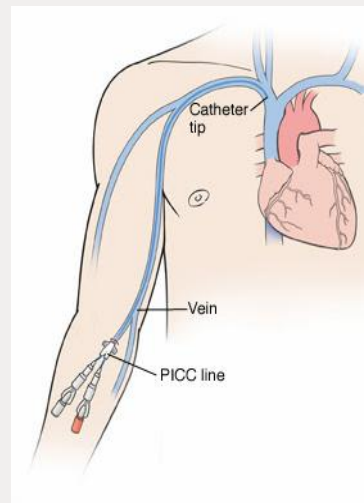
ว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ์(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 19 ก.ค 62 มีผลใช้บังคับ 20 ก.ค 62

เงื่อนไขการเจาะเก็บตัวอย่างเลือด



- ให้เจาะเก็บจากเส้นเลือดดำส่วนปลายหรือเส้นเลือดฝอยปลายนิ้ว
- การจัดเก็บตัวอย่างเลือดจากเส้นเลือดแดง ให้เก็บจากช่องที่แพทย์เปิดไว้แล้วเท่านั้น
- ต้องเป็น แนวทางเวชปฏิบัติ (CPG) หรือแนวทางการพยาบาล(CNPG)
- ห้ามเป็นผู้ตรวจวินิจฉัย ให้ส่งตัวอย่างเลือดไปยังหน่วยตรวจวิเคราะห์
- **เว้นแต่**เป็นการตรวจวินิจฉัยแก่ผู้รับบริการเฉพาะรายที่ตนดูแลในลักษณะการตรวจ ณ จุดดูแลผู้ป่วย (Point of care testing) เช่น การตรวจระดับน้ำตาลในผู้ป่วยเบาหวาน เป็นต้น



ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบ วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2564



การรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรค

รักษาโรคเบื้องต้นและให้ภูมิคุ้มกันโรค ดังต่อไปนี้ ใช้ตัวร้อน ใช้และมีฝิ่นหรือจุด ใช้จับสัน
ไข้อ ปวดศีรษะ **ปวดเมื่อย** ปวดหลัง ปวดเอว ปวดท้อง ท้องผูก ท้องเดิน คลื่นไส้ อาเจียน การอักเสบต่าง
ๆ โลหิตจาง ดีซ่าน โรคขาดสารอาหาร อาหารเป็นพิษ โรคพยาธิลำไส้ โรคบิด โรคไข้หวัด โรคหัด โรค
สุกใส โรคคางทูม โรคไอกรน โรคผิวหนัง **เหน็บชา** **ปวดฟัน** **เหงือกอักเสบ** **เจ็บตา** **เจ็บหู** โรคติดต่อ
ตามประกาศกระทรวง **ภาวะแท้งคุกคามหรือหลังแท้งแล้ว** การให้ภูมิคุ้มกันแก่บุคคลทั่วไป หญิงมี
ครรภ์ หญิงหลังคลอด ทารกและเด็ก และความเจ็บป่วยอื่น ๆ ตามที่สภาการพยาบาลประกาศกำหนด

ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบ วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2564

การรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรค (ต่อ)

เป็นการกระทำโดย

- ตรวจวินิจฉัยและบำบัดรักษาโรค ตามมาตรฐานของการประกอบวิชาชีพการพยาบาลที่สภาการพยาบาลประกาศกำหนด
- ให้ส่งผู้ป่วยไปรับการบำบัดรักษาจากผู้ประกอบวิชาชีพอื่น เมื่อปรากฏ ตรวจพบหรือพิจารณาแล้วเห็นว่าอาการไม่บรรเทา อาการรุนแรงเพิ่มขึ้น มีโรคหรือภาวะแทรกซ้อน เป็นโรคติดต่อที่ต้องแจ้งความตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ หรือมีเหตุอันควรอื่น ๆ เกี่ยวกับการบำบัดรักษา
- ถ้าจำเป็นต้องใช้ยา ให้ใช้ยาได้ตามคู่มือการใช้ยาที่สภาการพยาบาลประกาศกำหนด
- การให้ภูมิคุ้มกันโรค ต้องปฏิบัติตามแนวทางการให้ภูมิคุ้มกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
- ต้องมีการบันทึกรายงานเกี่ยวกับประวัติของผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ อาการ และการเจ็บป่วย โรค การพยาบาล การให้การรักษา หรือการให้บริการ วันเวลาในการให้บริการ ชื่อผู้ประกอบวิชาชีพ ตามความเป็นจริง ตามแบบของสภาการพยาบาล เก็บบันทึกและรายงานไว้เป็นหลักฐานเป็นเวลา 5 ปี

ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2564

การพยาบาลก่อนการตั้งครรภ์ ระยะตั้งครรภ์

- ▶ การผดุงครรภ์แก่หญิงและครอบครัว เมื่อต้องการมีบุตร ก่อนการตั้งครรภ์ ระยะตั้งครรภ์ด้วยกระบวนการ
 1. การตรวจประเมินภาวะสุขภาพของหญิงและคู่สมรสเพื่อวางแผนการมีบุตร
 2. การตรวจประเมินภาวะการตั้งครรภ์ด้วยเวชภัณฑ์ทดสอบการตั้งครรภ์
 3. การรับฝากครรภ์



ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบ วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2564

การพยาบาลก่อนการตั้งครรภ์ ระยะตั้งครรภ์

- ▶ การแนะนำและส่งต่อหญิงมีครรภ์ให้ได้รับการตรวจและรักษากับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามเกณฑ์การฝากครรภ์ที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด
- ▶ การส่งต่อหญิงมีครรภ์กลุ่มเสี่ยง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข หรือการตรวจพบภาวะครรภ์เป็นพิษ (Pre-eclampsia) หรือส่วนน้ำหนักหรือท่าของทารกในครรภ์ผิดปกติ หรือมีภาวะความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์และการคลอดอื่น ๆ ให้ได้รับการรักษาพยาบาลจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือส่งต่อไปสถานพยาบาลที่มีความพร้อม เพื่อความปลอดภัยของหญิงมีครรภ์และทารก

ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบ วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2564

การพยาบาลระยะคลอด

ให้การผดุงครรภ์ได้แต่เฉพาะรายที่ตั้งครรภ์ปกติ และคลอดอย่างปกติ ตลอดจนการดูแลมารดาและทารกแรกเกิด

▶ ระยะก่อนคลอด

▶ ระยะคลอด (Intrapartum) ได้แก่

1. การพยาบาลหญิงมีครรภ์ที่ได้รับการชักนำการคลอด (Induction of labour)

2. การทำคลอดในรายปกติ เตรียมทำคลอดเมื่อปากมดลูกเปิดสมบูรณ์แล้ว ส่วนน้ำอยู่ในอุ้งเชิงกรานพร้อมคลอด ตัดฝีเย็บตามข้อบ่งชี้ การทำคลอด การดูแลทารกแรกเกิดทันที

3. การทำคลอดรก และเยื่อหุ้มทารกโดยใช้วิธี Modified Credé Maneuver การตรวจรกและเยื่อหุ้มรก ในรายที่รูก้างถ้าปล่อยไว้จะเป็นอันตรายต่อมารดาให้ทำคลอดรกด้วยวิธีพยุงดึงรังสายสะดือ (Controlled cord traction) ถ้ารกไม่คลอดให้ส่งต่อผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือส่งต่อไปสถานพยาบาลที่มีความพร้อมทันที

4. การเย็บซ่อมแซมฝีเย็บ ในรายที่มีการฉีกขาดที่ไม่เกินระดับ 2 (Second degree tear)

ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบ วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2564

การพยาบาลระยะคลอด (ต่อ)

5. การประเมินการเสียเลือด

6. การประเมินสัญญาณชีพหลังคลอดทันทีและก่อนการย้ายออกจากห้องคลอด

7. การช่วยเหลือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมทำคลอดในรายที่มีการคลอดผิดปกติ เช่น การคลอดติดไหล่ หน้า หรือการใช้เครื่องมือช่วยคลอดด้วยเครื่องสุญญากาศ ด้วยคีม หรือการช่วยทำผ่าตัดคลอด การช่วยทำหัตถการทางสูติกรรมที่มีความปลอดภัยต่อหญิงมีครรภ์

9. การช่วยคลอดฉุกเฉินในรายที่มีการคลอดผิดปกติที่ไม่สามารถตรวจพบก่อนการทำคลอด และไม่สามารถหาผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมทำการคลอดได้ภายในเวลาอันสมควรและเห็นประจักษ์ว่า ถ้าละเลยไว้จะเป็นอันตรายต่อมารดาหรือทารกก็ให้ทำคลอดในรายเช่นนั้นได้ แต่ห้ามให้ใช้คีมสูงในการทำคลอด หรือใช้เครื่องดูดสุญญากาศในการทำคลอด หรือทำการผ่าตัดในการทำคลอดหรือให้ยารัดมดลูกก่อนคลอด

10. ในรายที่การตกเลือดหลังคลอด ถ้าปล่อยทิ้งไว้จะเป็นอันตรายต่อมารดาให้รักษาอาการตกเลือดเบื้องต้นตามความจำเป็นและส่งต่อทันที

ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบ วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2564

การพยาบาลระยะคลอด (ต่อ)

ห้ามพยาบาลวิชาชีพกระทำการที่เกี่ยวกับการคลอด ดังนี้

- การเจาะน้ำคร่ำเพื่อตรวจภาวะการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ (amniocentesis)
- การทำคลอดที่มีความผิดปกติ เช่น คลอดท่าก้น คลอดแฝด สายสะดือย้อย คลอดท่าขวาง หรือภาวะที่ส่วนหน้าใหญ่กว่าช่องเชิงกราน เป็นต้น
- การล้วงรก (Manual removal of placenta)
- การกลับท่าของทารกในครรภ์ ทั้งภายในและภายนอกครรภ์ (internal and external version)
- การใช้มือกดท้องในขณะช่วยทำคลอด
- การเย็บซ่อมแซมฝีเย็บที่มีการฉีกขาดระดับ 3
- การทำแท้ง

ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบ วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2564

การพยาบาลระยะหลังคลอด

1. การให้การพยาบาลมารดาหลังคลอดอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน โดยเฉพาะภาวะตกเลือดหลังคลอด และหรืออาการอื่นที่อาจเกิดขึ้น
2. พยาบาลวิชาชีพจะต้องใช้ยาทำลายและป้องกันการติดเชื้อสำหรับหยอดตา หรือป้ายตาทารกแรกเกิดทันที
3. การพยาบาลทารกแรกเกิด โดยการประเมินสัญญาณชีพ ความผิดปกติ หรือความพิการที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และให้มารดาได้สัมผัสโอบกอดทารกและเริ่มให้ดูดนมจากมารดาภายในชั่วโมงแรกหลังคลอด
4. พยาบาลวิชาชีพจะต้องบันทึกรายงานเกี่ยวกับประวัติของหญิงตั้งครรภ์ การพยาบาลระยะตั้งครรภ์ การคลอด การพยาบาลหลังคลอด การให้การบริการตามความเป็นจริงตามแบบของสภาการพยาบาลและต้องเก็บบันทึกรายงานไว้เป็นหลักฐาน เป็นระยะเวลา 5 ปี

ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบ วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2564

การวางแผนครอบครัวและการคัดกรองมารดาทารก

1. การให้คำปรึกษากับคู่สมรสในการวางแผนครอบครัว แบบวิถีธรรมชาติ/การคุมกำเนิดด้วยวิธีธรรมชาติไม่ต้องใช้ยาหรืออุปกรณ์
2. การให้บริการวางแผนครอบครัวแบบใช้ยาหรืออุปกรณ์
 - ยาเม็ดคุมกำเนิด (Oral contraceptive pills)
 - ยาฉีดคุมกำเนิด (DMPA)
 - ถุงยางอนามัย
 - วงแหวนคุมกำเนิด
 - แผ่นแปะคุมกำเนิด/ยาคุมกำเนิดชนิดแผ่นแปะผิวหนัง
 - การฝังและถอดยาคุมกำเนิด (Nor Plant)
 - การวางแผนครอบครัวแบบอื่น ๆ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบ วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2564

การวางแผนครอบครัวและการคัดกรองมารดาทารก (ต่อ)

3. การคัดกรองมารดาทารก ด้วยการ

- ทำ Pap smear
- ประเมินภาวะสุขภาพ ความผิดปกติและความพิการของทารก

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558



ความหมายศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

โรคติดต่อ

โรคที่เกิดจากเชื้อโรคหรือพิษของเชื้อโรค ซึ่งแพร่โดยตรงหรืออ้อมมาสู่คน

โรคติดต่ออันตราย

โรคติดต่อที่มีความรุนแรงสูง และแพร่ไปสู่ผู้อื่นได้อย่างรวดเร็ว

โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง

โรคติดต่อที่ต้องติดตามตรวจสอบ หรือจัดเก็บข้อมูลต่อเนื่อง

โรคระบาด

โรคติดต่อหรือโรคที่ยังไม่ทราบสาเหตุการเกิดโรคแน่ชัด อาจแพร่ไปสู่ผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง หรือมีภาวะของการเกิดโรคมามากผิดปกติกว่าที่เคยเป็นมา

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558



ความหมายศัพท์ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

พาหะ

คนหรือสัตว์ซึ่งไม่มีอาการของโรคติดต่อ แต่ร่างกายมีเชื้อโรคนั้นที่อาจติดต่อถึงผู้อื่นได้

ผู้สัมผัสโรค

คนที่ได้เข้าใกล้ชิดคน สัตว์ หรือสิ่งของติดโรค จนเชื่อโรคนั้นอาจติดต่อถึงผู้นั้น

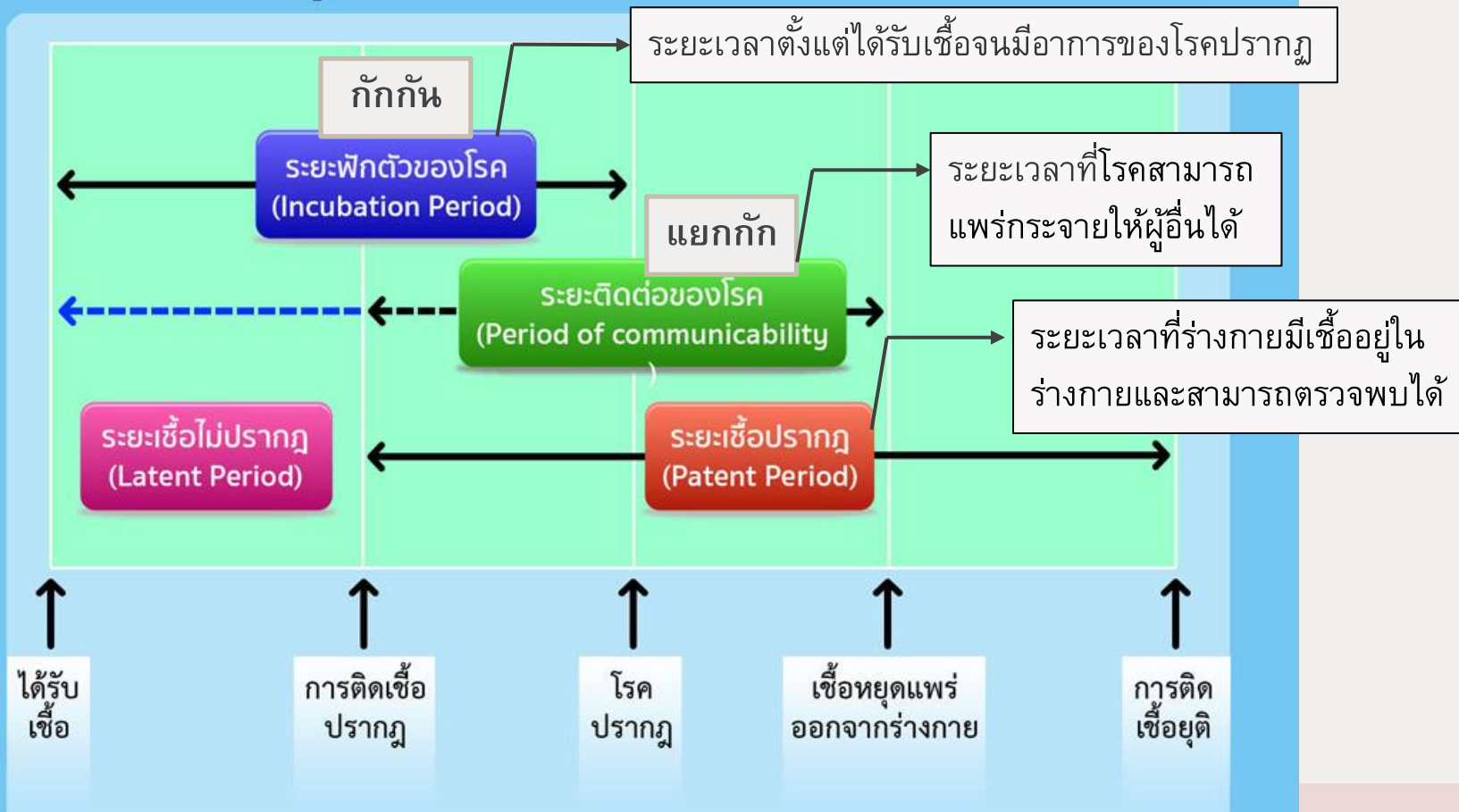
แยกกัก

การแยกผู้สัมผัสโรคหรือพาหะไว้ต่างหากจากผู้อื่นในที่เอกเทศ เพื่อป้องกันมิให้เชื้อโรคแพร่โดยตรงหรือทางอ้อมไปยังผู้ซึ่งอาจได้รับเชื้อโรคนั้น ๆ ได้ จนกว่าจะพ้นระยะติดต่อของโรค

กักกัน

การควบคุมผู้สัมผัสโรคหรือพาหะให้อยู่ในที่เอกเทศ เพื่อป้องกันมิให้เชื้อโรคแพร่โดยตรงหรือทางอ้อมไปยังผู้ซึ่งอาจได้รับเชื้อโรคนั้น ๆ ได้ จนกว่าจะพ้นระยะฟักตัวของโรคหรือจนกว่าจะพ้นความเป็นพาหะ

การควบคุมโรค



พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558



โรคติดต่ออันตราย

ผู้มีอำนาจประกาศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เงื่อนไข

โดยคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

จำนวน

14 โรค

โรคติดต่ออันตราย

โรคติดต่ออันตรายทั้งหมด 13 โรค ได้แก่

1. กาฬโรค (Plague) การติดต่อ

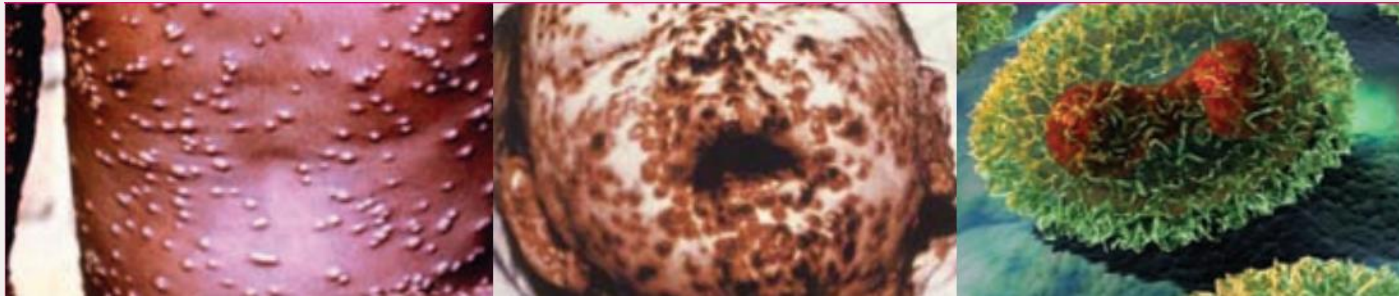
1. หมัดหนูมากัดคนแล้วปล่อยเชื้อกาฬโรคเข้าทางบาดแผล หรือทางผิวหนังที่ถลอกจากการเกา บริเวณที่ถูกหมัดหนูกัด
2. ติดต่อกับการสูดหายใจเอาละอองเสมหะที่มีเชื้อของผู้ป่วยที่ไอ จาม หรือ จากสัตว์ที่มีเชื้อโรค

เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
โดยมีหมัดเป็นพาหะนำโรค



โรคติดต่ออันตราย

2. ไข้ทรพิษหรือฝีดาษ (Smallpox) เกิดจากเชื้อไวรัสวาริโอลา (Variola virus) เกิดขึ้นเฉพาะในคนเท่านั้น ไม่พบแหล่งรังโรคในสัตว์หรือสิ่งแวดล้อม การติดต่อกับมักเกิดขึ้นในระบบทางเดินหายใจ ซึ่งอาจติดจากละอองฝอย หรือการติดเชื้อทางผิวหนัง



โรคติดต่ออันตราย

3. ไข้เลือดออกโครเมียนคองโก (Crimean – Congo hemorrhagic fever) เกิดจากเชื้อบunyavirus (bunyavirus) โรคนี้พบได้ในแถบยุโรปตะวันออก ตะวันออกกลาง แอฟริกา เอเชียกลาง และเอเชียใต้ ติดต่อโดย

1. เชื้อเข้าสู่ร่างกายโดยถูกเห็บที่มีเชื้อไวรัสกัด หรือจากการจับต้องเห็บ หรือการบีบเห็บด้วยมือเปล่า เชื้อไวรัสสามารถมีชีวิตอยู่ในตัวเห็บได้ตลอดชีวิต
2. เกิดจากการสัมผัสกับเลือดหรือสารคัดหลั่ง จากสัตว์เลี้ยง (เช่น แพะ แกะ วัว ควาย นกกระเจือกเทศ) และสัตว์ป่ากินพืชที่มีเชื้อไวรัสอยู่ในกระแสเลือด แต่สัตว์เหล่านี้ไม่แสดงอาการป่วย
3. การติดต่อจากคนสู่คน โดยสัมผัสกับเลือดหรือสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย



โรคติดต่ออันตราย

4. ไข้เวสต์ไนล์ (West Nile Fever) เกิดจากไวรัสเวสต์ไนล์เป็นเชื้อไวรัสที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับโรคไข้สมองอักเสบ (Japanese encephalitis) โดยไวรัสกลุ่มนี้พบได้ทั่วไปในแอฟริกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลาง และยุโรป พบเชื้อในยุง *Culex* spp. หรือ *Aedes* spp.



โรคติดต่ออันตราย

5. ไข้เหลือง (Yellow Fever) มีศูนย์กลางเป็นพาหะ นำเชื้อจากผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้เหลืองไปสู่คนปกติ เป็นโรคประจำถิ่นของประเทศแถบแอฟริกา และทวีปอเมริกาใต้



โรคติดต่ออันตราย

6. โรคไข้ลาสซา (Lassa fever) เป็นโรคในแถบแอฟริกาตะวันตก มีหนูเป็นพาหะนำโรค การติดต่อ
1. เกิดจากการได้รับเชื้อผ่านละอองฝอยในอากาศ หรือการสัมผัสโดยตรงกับของเสียที่ขับถ่ายออกมาจากหนูที่ติดเชื้อ ซึ่งติดอยู่ตามพื้นผิวต่างๆ
 2. ติดเชื้อผ่านสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย เช่น เสมหะ และปัสสาวะ ซึ่งแพร่ออกมาในระยะที่มีไข้เฉียบพลัน นอกจากนี้ยังสามารถแพร่เชื้อจากคนสู่คนทางเพศสัมพันธ์ ผ่านทางน้ำอสุจิได้นานถึง 3 เดือนภายหลังการติดเชื้อ
 3. ติดเชื้อในห้องปฏิบัติการและจากการฉีดยาโดยใช้เข็มที่ปนเปื้อนเชื้อระยะพักตัวของโรค โดยทั่วไปอยู่ระหว่าง 6 - 21 วัน



โรคติดต่ออันตราย

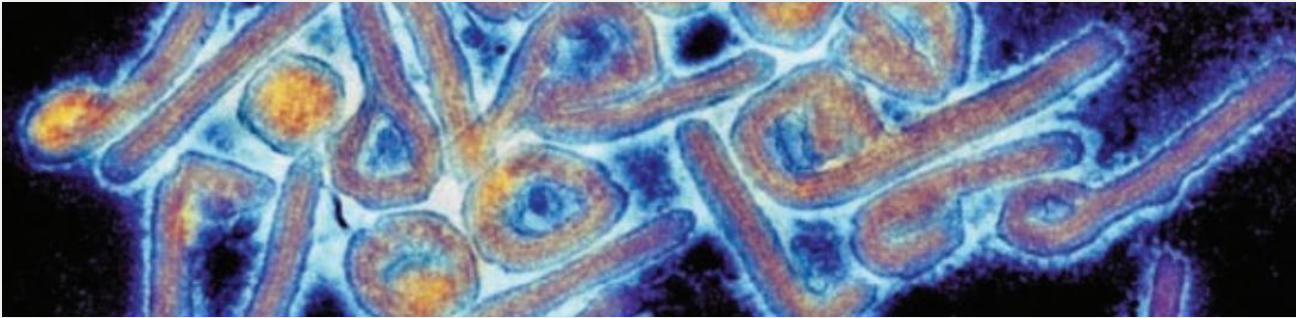
7. โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ (Nipah virus disease) ระบาดครั้งแรกในหมู่บ้านสุโงนิปาห์ ประเทศมาเลเซีย ติดต่อด้วยค้างคาวกินผลไม้แต่เชื้อไวรัสไม่ก่อโรคในค้างคาว ไวรัสนิปาห์สามารถก่อโรคในสุกร สุนัขและม้า การแพร่โรคมายังคนเกิดจากการสัมผัสโดยตรงกับสุกร หรือผลิตภัณฑ์จากสุกร ที่ติดเชื้อ

Doctor John



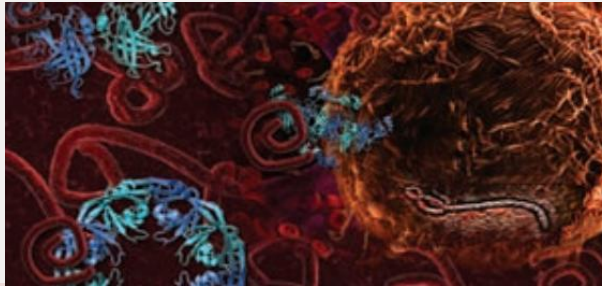
โรคติดต่ออันตราย

8. โรคติดเชื้อไวรัสมาร์บวร์ก (Marburg virus disease) เป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์ โดยมีค้างคาวกินผลไม้เป็นแหล่งรังโรค การติดต่อจากคนสู่คนเกิดจากการสัมผัสโดยตรงกับเลือด ปัสสาวะ อาเจียน อุจจาระ หรืออสุจิ



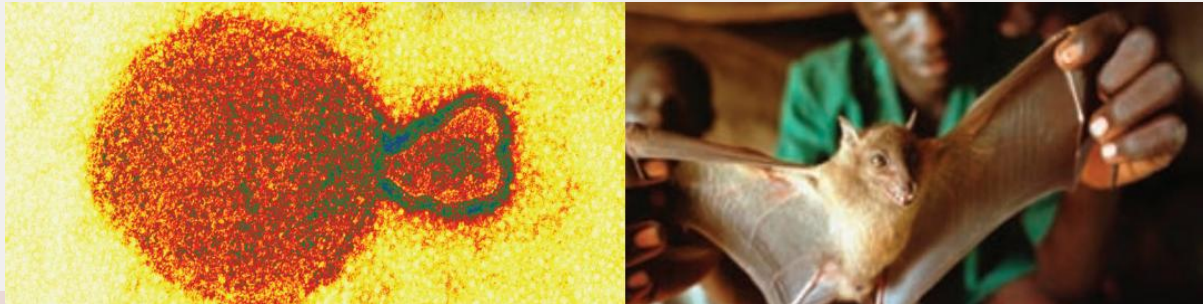
โรคติดต่ออันตราย

9. โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola virus disease – EVD) มีการแพร่ระบาดในแถบแอฟริกาตะวันตก การติดต่อจากคนสู่คน เกิดจากการสัมผัสตรงกับเลือดที่ติดเชื้อ สารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำลาย ปัสสาวะ อุจจาระ อ้วก หรือน้ำอสุจิ โดยการติดต่อของเชื้อไวรัสอีโบลาสู่คนเกิดจากการสัมผัสโดยตรงกับเลือด หรือเครื่องในของสัตว์ป่าที่ติดเชื้อ หรือเกิดขณะจัดการหรือชำแหละสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ตายแล้ว



โรคติดต่ออันตราย

10. โรคติดเชื้อไวรัสเฮนดรา (Hendra virus disease) ค้างคาวกินผลไม้เป็นพาหะสำคัญ แต่เชื้อไวรัสไม่ก่อโรคในค้างคาว แต่ก่อโรคในม้า การติดเชื้อในคนเกิดจากการสัมผัสโดยตรงกับม้าหรือผลิตภัณฑ์จากม้า หรือ ติดเชื้อจากการปนเปื้อนของสารคัดหลั่งจากสัตว์ที่ติดเชื้อมายังบาดแผลหรือรอยถลอก



โรคติดต่ออันตราย

11. โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (Severe Acute Respiratory Syndrome – SARS) เกิดจากไวรัสโคโรนา (Coronavirus) โรคซาร์สติดต่อกันระหว่างคนสู่คนโดยการสัมผัสโดยตรงกับน้ำมูก น้ำลาย และสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย หรือแพร่ผ่านสิ่งของเครื่องใช้ หรือละอองฝอยจากระบบทางเดินหายใจ จากการดูแลหรืออาศัยอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อ



โรคติดต่ออันตราย

12. โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (Middle East Respiratory Syndrome – MERS) เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา การแพร่เชื้อระหว่างคนสู่คนสามารถแพร่ผ่านทางละอองฝอยของผู้ป่วยจากการไอ และมักเกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโดยไม่ได้มีการป้องกันตนเอง บางรายมีประวัติเคยสัมผัสกับสัตว์ และดื่มน้ำนมดิบจากสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากอูฐ



โรคติดต่ออันตราย

13. วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (Extensively drug – resistant tuberculosis : XDR-TB) โรควัณโรคที่มีการดื้อยา 4 ขนานร่วมกัน ได้แก่ ไอโซไนอะซิด (Isoniazid) ไรแฟมพิซิน (Rifampicin) กลุ่มยาฟลูออโรควิโนโลน (Fluoroquinolones) และกลุ่มยาทางเลือกรุ่นที่สอง ที่เป็นยาชนิดฉีด (Second-line injectable drugs) ติดต่อกับการสูญหายใจอากาศที่มีเชื้อเข้าไป ซึ่งเชื้อโรคนี้มีคุณสมบัติพิเศษ คือ มีความคงทนต่ออากาศแห้ง ความเย็น ความร้อน สารเคมี และอยู่ในอากาศได้นาน ยกเว้นไม่ทนทานต่อแสงแดด



ไวรัสฮันตา

Orthohantavirus Hantavirus

หรือ

เป็นไวรัสในสกุล *Hantaviridae* พบในหนูและสัตว์ฟันแทะ ทำให้เกิดการติดเชื้อในหนูโดยไม่มีอาการ แต่สามารถแพร่เชื้อสู่คนได้ เคยพบผู้ติดเชื้อในประเทศไทยบ้าง แต่น้อยมาก

▶ ระยะฟักตัวประมาณ 1-8 สัปดาห์ ◀
หลังสัมผัสเชื้อ

อาการของโรค

ไข้ ปวดเมื่อย อ่อนเพลีย คล้ายไข้หวัดใหญ่
อาการมีได้ตั้งแต่มักรุนแรงจนถึงอันตรายถึงชีวิต

1. กลุ่มอาการทางไต (HFRS)

พบมาก : ทวีปเอเชียและยุโรป
อาการคล้ายไข้เลือดออก มีไข้ เลือดออกผิวดิบ
ความดันโลหิตต่ำ ไตวายเฉียบพลัน

2. กลุ่มอาการทางปอด (HPS)

พบมาก : ทวีปอเมริกา
อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ มีไข้ ปวดเมื่อย
อ่อนเพลีย ปอดอักเสบรุนแรงและ
หายใจล้มเหลวอย่างรวดเร็ว



พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง

ผู้มีอำนาจประกาศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เงื่อนไข

โดยคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

จำนวน

57 โรค

โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง

โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทั้งหมด 57 โรค ได้แก่

1. กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง (Lymphogranuloma Venereum หรือ Granuloma Inguinale)
2. การติดเชื้อในโรงพยาบาล (Health care-associated infection หรือ hospital-acquired)
3. ไข้กาฬหลังแอ่น (Meningococcal meningitis)
4. ไข้ดำแดง (Scarlet fever)
5. ไข้เด็งกี (Dengue Fever)
6. ไข้ปวดข้อยุ่งลาย (Chikungunya fever)
7. ไข้มาลาเรีย (Malaria)
8. ไข้ไม่ทราบสาเหตุ (Pyrexia of Unknown origin/Fever of Unknown Origin/Fever caused)
9. ไข้สมองอักเสบชนิดญี่ปุ่น (Japanese Encephalitis)
10. ไข้สมองอักเสบไม่ระบุเชื้อสาเหตุ (Unspecified encephalitis)
11. ไข้หวัดนก (Avian Influenza)
12. ไข้หวัดใหญ่ (Influenza)
13. ไข้หัด (Measles)

โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ต่อ)

14. ไข้มั้ดเยอรรมัน (Rubella)
15. ไข้เอนเทอริค (Enteric fever)
16. ไข้เอนเทอโรไวรัส (Enterovirus)
17. คอตีบ (Diphtheria)
18. คางทูม (Mumps)
19. ซิฟิลิส (Syphilis)
20. บาดทะยัก (Tetanus)
21. โปลิโอ (Poliomyelitis)
22. แผลริมอ่อน (Cancroid)
23. พยาธิทริคิเนลลา(Trichinosis)
24. พยาธิใบไม้ตับ (Liver fluke)
25. เมลิออยโดสิส(Melioidosis)
26. เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากพยาธิ (Eosinophilicmeningitis)
27. เยื่อหุ้มสมองอักเสบไม่ระบุเชื้อสาเหตุ (Unspecified meningitis)

โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ต่อ)

28. เริ่มของอวัยวะสืบพันธุ์และทวารหนัก (Anogenital Herpes)
29. โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัสชนิด เอ บี ซี ดี และ อี (Viral hepatitis A, B, C, D and E)
30. โรคตาแดงจากไวรัส (Viral conjunctivitis)
31. โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zikavirus disease)
32. โรคติดเชื้อสเตรปโตคอคคัสซูอิส (Streptococcus suis)
33. โรคเท้าช้าง (Elephantiasis Lymphatic Filariasis)
34. โรค布鲁เซลโลสิส (Brucellosis)
35. โรคปอดอักเสบ (Pneumonitis หรือ Pneumonia)
36. โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies)
37. โรคมือเท้าปาก (Hand Foot and Mouth disease)
38. โรคเรื้อน (Leprosy)
39. โรคไลชมาเนีย (Leishmaniasis)
40. โรคเลปโตสไปโรสิส (Leptospirosis)

โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ต่อ)

41. โรคสครับไทฟัส (Scrub typhus)
42. โรคสุกใส หรืออีสุกอีใส (Varicella, Chickenpox)
43. โรคอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน (Acute Flaccid Paralysis : AFP)
44. โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute diarrhea)
45. โรคเอดส์ (Acquired Immunodeficiency Syndrome : AIDS)
46. โรคแอนแทรกซ์ (Anthrax)
47. วัณโรค (Tuberculosis)
48. ไวรัสตับอักเสบบีไม่ระบุเชื้อสาเหตุ (Hepatitis)
49. หนองใน (Gonorrhea)
50. หนองในเทียม (Non Gonococcal Urethritis : NGU)
51. หูดอวัยวะเพศและทวารหนัก (Condyloma Acuminata หรือ Venereal Warts)
52. อหิวาตกโรค (Cholera)

โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ต่อ)

- 53. อาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (Adverse Event Following Immunization : AEFI)
- 54. อาหารเป็นพิษ (Food poisoning)
- 55. ไอกรน (Pertussis)
- 56. โรคฝีดาษวานรหรือโรคฝีดาษลิง (Monkeypox)
- 57. โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

โรคระบาด

ผู้มีอำนาจประกาศ

อธิบดีกรมควบคุมโรค

เงื่อนไข

โดยคำแนะนำของคณะกรรมการด้านวิชาการ

อำนาจ

ประกาศชื่อ อาการสำคัญ และสถานที่ที่มีโรคระบาด

ประกาศยกเลิกเมื่อสภาวะการณ์ของโรคนั้นสงบลง
หรือกรณีมีเหตุอันสมควร

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

กลไกการเฝ้าระวังโรคติดต่อ

เมื่อมีโรคติดต่ออันตราย
โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือ
โรคระบาด



- (1) กรณีพบในบ้าน => เจ้าบ้านหรือผู้
ควบคุมดูแลบ้านหรือแพทย์ผู้ทำการรักษา
- (2) กรณีพบในสถานพยาบาล => ผู้รับผิดชอบใน
สถานพยาบาล
- (3) กรณีเมื่อได้มีการชันสูตรตรวจพบว่าอาจจะม
ีเชื้ออันเป็นเหตุของโรคติดต่อดังกล่าว => ผู้ทำ
การชันสูตรหรือผู้รับผิดชอบในสถานที่ที่ได้มีการ
ชันสูตร
- (4) กรณีพบในสถานประกอบการ => เจ้าของ
หรือผู้ควบคุมสถานที่



เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้ง
ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรี
กระทรวงสาธารณสุข
ประกาศกำหนด

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตราย
โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึ้น พ.ศ. 2560

โรคติดต่ออันตราย



- เจ้าบ้าน/ผู้ควบคุมดูแลบ้าน/
แพทย์ผู้ทำการรักษาพยาบาล
- เจ้าของ/ผู้ควบคุมสถาน
ประกอบการ



เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อสังกัดกรมควบคุม
โรคในส่วนกลาง/ในพื้นที่



- ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล
- ผู้ทำการชันสูตร/ผู้รับผิดชอบ
ในสถานที่ที่ได้มีการชันสูตร



เจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อสังกัดกรม
ควบคุมโรคในส่วนกลาง



ภายใน 3 ชั่วโมงนับแต่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตราย
โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึ้น พ.ศ. 2560

โรคระบาด

- เจ้าบ้าน/ผู้ควบคุมดูแลบ้าน/แพทย์ผู้ทำการ
รักษาพยาบาล
- เจ้าของ/ผู้ควบคุมสถานประกอบการ
- ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล
- ผู้ทำการชันสูตร/ผู้รับผิดชอบในสถานที่ที่ได้มีการ
ชันสูตร



เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่



ภายใน 24 ชั่วโมงนับแต่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตราย
โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดเกิดขึ้น พ.ศ. 2560

โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง



- ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล
- ผู้ทำการชันสูตร/ผู้รับผิดชอบในสถานที่ที่ได้มีการชันสูตร



1. เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในสังกัด สสจ.
2. เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในสังกัดสำนัก
อนามัย กทม.



ภายใน 7 วันนับแต่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545



①บุคคลสัญชาติไทย

②มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

③ไม่มีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลอื่น

บุคคลที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้แก่

- เด็กแรกเกิด ที่ไม่มีสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการจากบิดามารดา
- บุตรข้าราชการที่บรรลุนิติภาวะ (อายุ 20 ปีขึ้นไป หรือสมรส) และไม่มีสิทธิประกันสุขภาพจากหน่วยงานรัฐ
- บุตรข้าราชการคนที่ 4 ขึ้นไป และไม่มีสิทธิประกันสุขภาพจากหน่วยงานรัฐ
- ผู้ประกันตนที่ขาดการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม (หมดสิทธิประกันสังคม)
- ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการหรือออกจากราชการโดยมิได้รับบำนาญ
- ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และไม่ได้เป็นผู้ประกันตน



กลุ่มคนเหล่านี้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามกฎหมาย และสามารถลงทะเบียนเพื่อเลือกหน่วยบริการประจำโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย “ใกล้บ้าน ใกล้ใจ”

แต่ครั้ง

“ค่าบริการ” หมายความว่า เงินที่ผู้รับบริการจ่ายให้แก่หน่วยบริการในการรับบริการสาธารณสุข

“ค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข” หมายความว่า ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ ได้แก่

- (๑) ค่าสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค
- (๒) ค่าตรวจวินิจฉัยโรค
- (๓) ค่าตรวจและรับฝากครรภ์
- (๔) ค่าบำบัดและบริการทางการแพทย์
- (๕) ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอวัยวะเทียม และค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์
- (๖) ค่าทำคลอด
- (๗) ค่ากินอยู่ในหน่วยบริการ
- (๘) ค่าบริบาลทารกแรกเกิด
- (๙) ค่ารถพยาบาลหรือค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วย
- (๑๐) ค่าพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ
- (๑๑) ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย และจิตใจ
- (๑๒) ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นเพื่อการบริการสาธารณสุขตามที่คณะกรรมการกำหนด

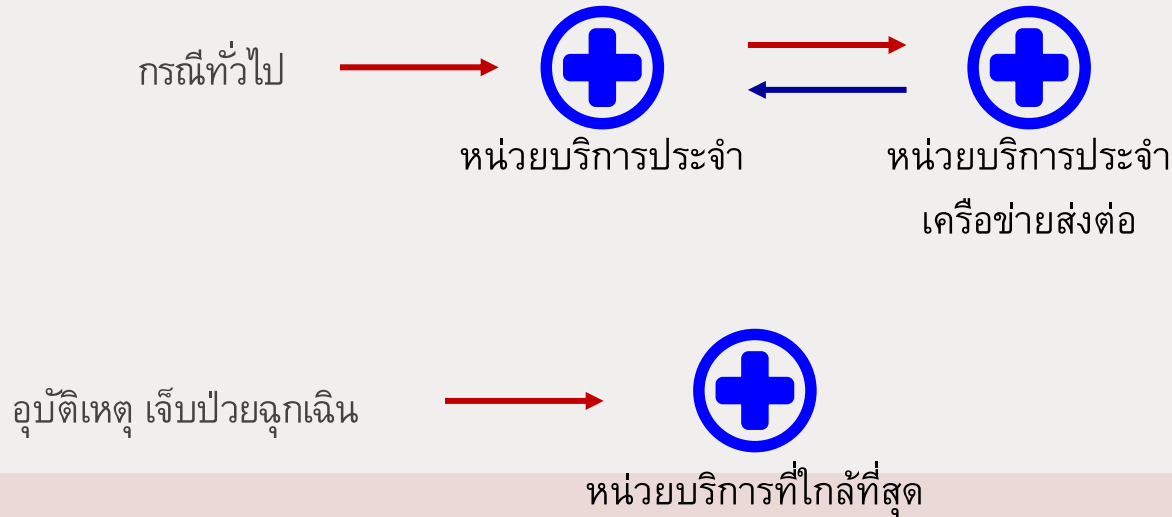
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545

วิธีการใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุข

1. กรณีทั่วไป ให้ใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุขที่หน่วยบริการประจำของตน หน่วยบริการปฐมภูมิในเครือข่ายหรือหน่วยบริการอื่นที่หน่วยบริการประจำของตนหรือเครือข่ายส่งต่อ
2. กรณีอุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน ให้รับเข้ารับบริการจากหน่วยบริการหรือสถานบริการอื่นที่ใกล้ที่สุดเป็นลำดับแรก



บริการที่คุ้มครอง ครอบครัว บริการที่จำเป็นต่อสุขภาพ และการดำรงชีวิต



1. การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแบ่งเป็น 5 กลุ่มวัย
2. การตรวจวินิจฉัยโรค เช่น การตรวจคัดกรองยีน human leucocyte antigen (HLA) สำหรับผู้ป่วย
เก๊าต์รายใหม่ที่ได้รับการรักษาด้วยยา allopurinol
3. การตรวจและรับฝากครรภ์ การทดสอบการตั้งครรภ์ การรับฝากครรภ์ การประเมินภาวะสุขภาพ
การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อคัดกรองธาลัสซีเมีย โรคดาวน์ซินโดรม หมู่เลือด การรักษาและป้องกัน
บาดทะยักและวัคซีนไข้วัดใหญ่ ยาเสริมธาตุเหล็ก กรดโฟลิก ดูแลภาวะทุพโภชนาการ รวมถึงการส่ง
ต่อกรณีเกิดความเสี่ยง



บริการที่คุ้มครอง ครอบครัว
บริการที่จำเป็นต่อสุขภาพ
และการดำรงชีวิต



4. การบำบัด และการบริการทางการแพทย์มีขอบเขตดังนี้

- 4.1 การปลูกถ่ายหัวใจ
- 4.2 การปลูกถ่ายตับในเด็กอายุไม่เกิน 18 ปีที่มีตับวายจากโรคท่อน้ำดีตีบตันแต่กำเนิดหรือตับวายจากโรคอื่นๆ
- 4.3 การรักษาผู้ป่วยจิตเวชกรณีต้องรับเป็นผู้ป่วยในเกินกว่า 15 วัน
- 4.4 การรับบริการกรณีโรคโควิด 19
- 4.5 บริการฝังเข็มหรือฝังเข็มร่วมกับการกระตุ้นไฟฟ้าในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ เพื่อฟื้นฟูสภาพตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
- 4.6 การผ่าตัดปลูกถ่ายตับในผู้ป่วยโรคตับแข็ง ระยะกลางและระยะท้าย
- 4.7 การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาและสารเสพติด ยกเว้นการบริการบำบัดรักษาและฟื้นฟูตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด
- 4.8 การบริการสาธารณสุขต่อผู้ประสบภัยรถ ยกเว้นการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยรถ
- 4.9 การรักษาภาวะมีบุตรยากและการผสมเทียม ตามที่ สปสช กำหนด ยกเว้นการตั้งครรภ์แทน
- 4.10 การรักษาโรคเดี่ยวที่ต้องรับรักษาเป็นผู้ป่วยในเกิน 180 วัน



บริการที่คุ้มครอง ครอบครัว บริการที่จำเป็นต่อสุขภาพ และการดำรงชีวิต



5. ยา เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม และ อุปกรณ์ทางการแพทย์ มีขอบเขตตามกำหนด
6. การทำคลอด สามารถใช้สิทธิคลอดบุตรไม่จำกัดจำนวนครั้ง
7. ค่าอาหารและค่าห้องผู้ป่วยสามัญ
8. การบริบาลทารกแรกเกิด มีขอบเขต เช่น การป้องกันโรคทั่วไป โดยได้รับวัคซีนตามแผนกระทรวงสาธารณสุข การคัดกรองการได้ยิน รวมถึงการคัดกรองโรคที่เกิดจากการเผาผลาญผิดปกติ
9. บริการรถพยาบาลหรือบริการพาหนะรับส่งเพื่อการรักษาระหว่างหน่วยบริการ
10. บริการพาหนะ รับส่งผู้ทุพพลภาพ รวมถึงผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย ผ้าอ้อมทางเลือก ไม่เกิน 3 ชิ้นต่อคนต่อวัน



บริการที่คุ้มครอง ครอบครัว
บริการที่จำเป็นต่อสุขภาพ
และการดำรงชีวิต



11. การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ เช่น กายภาพบำบัด จิตบำบัด พฤติกรรมบำบัด ฟื้นฟูการมองเห็น การได้ยิน
12. บริการสาธารณสุขด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ ซึ่งต้องเป็นไปตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
13. บริการสาธารณสุขอื่นที่จำเป็นต่อสุขภาพ และการดำรงชีวิตที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กำหนดเพิ่มเติม



กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตถึงแก่ชีวิต

UCEP

(Universal Coverage for
Emergency Patients)

เจ็บป่วยฉุกเฉินถึงแก่ชีวิต ตามนโยบายของรัฐที่ประกาศใช้เมื่อ 1 เม.ย. 2555

"เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่"

1. หหมดสติ ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ
2. หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรง หายใจติดขัดมีเสียงดัง
3. ชี้นิ้วลง เหงื่อแตก ตัวเย็น หรือมีอาการชักร่วม
4. เจ็บหน้าอกเฉียบพลันรุนแรง
5. แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก พูดไม่ชัดแบบปัจจุบันทันด่วน หรือชักรต่อเนื่องไม่หยุด
6. มีอาการอื่นร่วมที่มีผลต่อการหายใจ ระบบการไหลเวียนโลหิต และระบบสมองที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต





การบริการที่
ไม่คุ้มครอง
เบิกไม่ได้

1. เพื่อความสวยงามโดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
2. การตรวจวินิจฉัยและการรักษาที่เกินความจำเป็นจากข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
3. การรักษาที่อยู่ระหว่างการค้นคว้าทดลอง
4. การปลูกถ่ายอวัยวะ และการบริการทางการแพทย์อื่น ที่ยังไม่มีในประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
5. การตรวจวินิจฉัยเพื่อนำผลไปประกอบคดีความต่างๆ
6. การตรวจ DNA โดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์

สิทธิการขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีได้รับความเสียหายจากการ รักษาพยาบาล



ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ที่ได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล
ของหน่วยบริการในระบบหลักประกันแห่งชาติ ซึ่งไม่ใช่
เป็นพยาธิสภาพของโรคหรือเหตุแทรกซ้อนของโรค มีสิทธิ
ได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น โดยผู้ที่ได้รับความเสียหาย
หรือทายาทหรือผู้อุปการะหรือหน่วยบริการที่ให้บริการ

ต้องยื่นคำร้องภายใน 2 ปี
นับตั้งแต่วันที่ทราบความเสียหาย

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550

ธรรมนูญสุขภาพของประเทศไทย

อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ (คสช.)

สิทธิและหน้าที่ของประชาชน



- มีสิทธิและหน้าที่ในการดำรงชีวิตในสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ
- สตรีต้องได้รับการสร้างเสริมและคุ้มครองสุขภาพทางเพศและระบบเจริญพันธุ์
- สุขภาพของเด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ คนด้อยโอกาสในสังคมและกลุ่มคนต่าง ๆ ต้องได้รับการสร้างเสริมและคุ้มครองอย่างเหมาะสม
- ผู้ใดนำข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลอื่นไปเปิดเผย อันทำให้บุคคลนั้นเสียหาย ย่อมมีความผิด เว้นแต่ได้รับความยินยอมหรือมีกฎหมายกำหนด
- บุคลากรด้านสาธารณสุขต้องแจ้งข้อมูลด้านสุขภาพที่เกี่ยวกับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ อย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจรับหรือไม่รับบริการ
- หากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขจะให้ผู้ใช้บริการเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ใช้บริการก่อน
- เมื่อเกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน หน่วยงานของรัฐที่มีข้อมูล ต้องเปิดเผยข้อมูลและวิธีป้องกันให้แก่ประชาชน โดยต้องไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550

หนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุข (ม.12)

การแสดงเจตนาล่วงหน้า (advanced directive)

มาตรา ๑๒ บุคคลมีสิทธิทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตน หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยได้

การดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง

เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขได้ปฏิบัติตามเจตนาของบุคคลตามวรรคหนึ่งแล้วมิให้ถือว่าการกระทำนั้นเป็นความผิดและให้พ้นจากความรับผิดชอบ

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550

หนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุข (ม.12)

หลักเกณฑ์และวิธีการในการทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุข ที่ควรพิจารณาประกอบการทำหนังสือดังนี้

1. หากผู้ทำหนังสือแสดงเจตนามีสติสัมปชัญญะดี ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมควรอธิบายให้ผู้ทำหนังสือแสดงเจตนาทราบภาวะและความเป็นไปของโรค เพื่อขอคำยืนยันหรือปฏิเสธในการทำหนังสือแสดงเจตนา
4. กรณีที่ผู้ทำหนังสือแสดงเจตนาอยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์ ให้ดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาได้เมื่อผู้นั้นพ้นจากสภาพการตั้งครรภ์
5. กรณีผู้ที่ทำหนังสือมีอายุต่ำกว่า 18 ปีต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองหรือญาติที่ให้การเลี้ยงดู
6. การทำหนังสือแสดงเจตนาในสถานบริการสาธารณสุข ควรมีพยานรู้เห็นในขณะทำหนังสือแสดงเจตนาทั้งสองฝ่าย เพื่อช่วยยืนยันความถูกต้อง ได้แก่ ฝ่ายคนใกล้ชิดของผู้ทำหนังสือแสดงเจตนา กับพยานฝ่ายผู้ให้การดูแลรักษา แต่ไม่ควรเป็นแพทย์เจ้าของไข้ หรือพยาบาลผู้จัดการรายกรณี เช่นเดียวกับการทำหนังสือแสดงเจตนาที่บ้านหรือสถานที่อื่น ต้องมีพยานด้วย
7. ผู้ทำหนังสือแสดงเจตนาควรจัดเก็บต้นฉบับหนังสือแสดงเจตนาไว้เอง หรือมอบให้บุคคลที่ใกล้ชิดเก็บรักษาไว้ และมอบสำเนาหนังสือให้แก่ญาติ พยานผู้ทำหน้าที่อธิบายความประสงค์ของผู้ทำหนังสือ หรือแพทย์เจ้าของไข้เพื่อให้ทราบความประสงค์

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550

หนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุข (ม.12)

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง แนวทางการปฏิบัติของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เกี่ยวกับหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต ดังนี้

1. เมื่อผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ได้รับหนังสือแสดงเจตนาฯ จากผู้รับ การพยาบาล ให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลฯ แจ้งให้แพทย์ผู้ให้การรักษารับทราบและพิจารณาหนังสือแสดงเจตนาฯ ดังกล่าว

1.1 กรณีแพทย์รับหนังสือแสดงเจตนาฯ ไว้ประกอบแผนการรักษาพยาบาล ให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลฯ บันทึกไว้ในบันทึกทางการแพทย์ โดยต้นฉบับหนังสือแสดงเจตนาฯ มอบให้กับผู้รับการพยาบาล และเก็บสำเนาหนังสือแสดงเจตนาฯ ไว้ในเวชระเบียน

1.2 กรณีแพทย์ไม่รับหนังสือแสดงเจตนาฯ แพทย์จะเป็นผู้ชี้แจงเหตุผลการคืนหนังสือแสดงเจตนาฯ

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550

หนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุข (ม.12)

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง แนวทางการปฏิบัติของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์เกี่ยวกับหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต ดังนี้

2. ผู้รับบริการขอทำหนังสือแสดงเจตนาฯ ให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลฯ ดำเนินการดังนี้

2.1 จัดให้ผู้รับบริการพบแพทย์ผู้ให้การรักษาเพื่อให้แพทย์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำหนังสือแสดงเจตนาฯ และการจัดทำหนังสือแสดงเจตนาฯ ให้เป็นไปตามระเบียบของหน่วยงาน โดยผู้จัดทำไม่ใช่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลฯ

2.2 บันทึกข้อมูลไว้ในบันทึกทางการแพทย์ โดยต้นฉบับหนังสือแสดงเจตนาฯ มอบให้กับผู้รับบริการ และเก็บสำเนาหนังสือแสดงเจตนาฯ ไว้ในเวชระเบียน